

Información Paciente

Nombre : Francisco Rodolfo Pavez Pavez
Edad : 77a 7m 28d
Dirección : San Nicolas 2623 V.Parq.San.Franc.

Rut : 5.071.874-3
Fecha Nacto: 18/09/1944
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0718154
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 5705 8147

N° Epicrisis
301050

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 18/03/2022 19:38

Días Estadía: 59

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básic

Fecha Egreso : 16/05/2022 08:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

crisis convulsiva

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

Antecedentes mórbidos: ACV ACM derecha secuelado con hemiparesia BC izquierda, HTA, Epilepsia, flutter auricular, hipotiroidismo, Cáncer de próstata tratado con RT + HT (sin control desde 2017)

Fármacos en uso:

Paracetamol 1 gr cada 8 hrs VO
Fenitoína 100 mg AM - 150 mg PM VO
Levotiroxina 100 mcg en ayunas VO
Omeprazol 20 mg/día VO
Carvedilol 6,25 mg 1/2 comprimido por día VO
Clonazepam 0,5 mg/noche VO
Atorvastatina 40 mg/noche VO
Lactulosa 20 cc c/12hrs para lograr deposiciones 1-2 veces al día VO

Antecedentes quirúrgicos: tiroidectomía

Alergias: (-)

Hábitos: no tabaco, no OH.

Tabaco: no OH: no Drogas: no

Inmunizaciones: Coronavirus 3 dosis

Hospitalizaciones previas: Si

25/04/2017: ACV ACM derecha.

18/01/2018: Síndrome Convulsivo

10/04/2018: Status Convulsivo. Neumonía Aspirativa.

04/02-11/02 Sepsis de foco urinario

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos. Al DAU de SU se describe que el 17/03 presentó caída con golpe cefálico, sin compromiso de conciencia. El día de la consulta (18/03) presenta posterior a almuerzo, cuadro de convulsión tónico clónica generalizada, familiar le aporta Clonazepam oral y es llevado a APS, en ese centro impresiona crisis convulsiva (no descrita

Fecha Epicrisis : 16/05/2022 08:02

Fecha Última Actualización: 16-05-2022 8:02:16

Página 2 de 2

clínica), se indica Diazepam 10 mg IM sin resolución por lo que se traslada a SU CASR.

Al ingreso se describe en status convulsivo, en este contexto se indica Lorazepam 4 mg ev + Fenitoina 1.5 gr carga EV con lo cual habría yugulado status. Neurología lo describe posteriormente en coma farmacológico. En plan de sedación profunda por al menos 24 horas y re evaluar, se decide IOT y VMI, sedación profunda. Se solicita TAC de cerebro que demuestra infarto consolidado de ACM derecha conocido, descrito por neurología sin hallazgos agudos, neurocirugía sin indicación de pabellón. En este contexto se decide traslado a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso:

- Compromiso de conciencia
- oStatus convulsivo
- oComa farmacológico
- Falla renal aguda KDIGO 3 + acidosis metabólica
- oGlobo vesical más hidroureteronefrosis bilateral NO resuelto
- Colección periprostática
- Antecedentes

Paciente con estadia hospitalaria prolongada, con varias interurrencias infecciosas que se trataron. Sin embargo paciente presenta evolución tórpida, en malas condiciones generales, con aumento de requerimientos de oxígeno suplementario, con compromiso de conciencia, sin respuesta a terapia médica. Se conversa con familia, quienes se encuentran de acuerdo en optimizar terapia sintomática y manejo compasivo. Finalmente, se constata fallecimiento del paciente el día 15/05 a las 21:40 hrs.

Diagnóstico de Egreso

Epilepsia -
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE OTROS SOLIDOS Y LIQUIDOS - trastorno de la deglucion severo
INFECCION DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO - A Baumanii multi resistente
OTROS DELIRIOS - delirium mixto

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se constata fallecimiento del paciente a las 21:40 hrs.

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Daniela Belén Reyes González
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/05/2022 08:02

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:49

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar